BUSINESS MODEL CANVAS · AKCIT CAMP 2026

SalUS.ia

Copiloto de triagem para UPAs e prontos-socorros do SUS e da rede privada. O modelo de negócio ainda é hipótese: quem paga, o preço e o caminho de compra precisam ser validados.

Já existe · Hipótese · Como validar

PARCERIAS-CHAVE

Quem são os parceiros principais?

UPA da universidade
acesso para entrevistas e candidata natural ao primeiro piloto

AKCIT Camp
mentoria de negócio e regulação, rede de parceiros e investidores

Modelos abertos
Ollama e Llama 3.1 rodando local, sem custo de licença

Revisor clínico
enfermeiro ou médico que confere regras e pesos linha a linha

Secretarias e OSS
abrem a porta das unidades da rede

Formalizar um conselheiro clínico; hoje o acesso a médicos é informal

ATIVIDADES-CHAVE

O que precisamos fazer bem?

Motor de regras
17 regras de cor e pesos explícitos, com teste de que nada reduz a pontuação

Extração do relato
agente que lê o texto livre e avaliação com gabarito

Fila da unidade
ordem por cor e pontuação, reclassificação e aviso de piora do paciente

Revisão clínica contínua
das regras de cada queixa

Conformidade
Anvisa, LGPD e comitê de ética

Implantação
instalação e treino da equipe de triagem

RECURSOS-CHAVE

Do que precisamos?

Protótipo
32 perguntas, 7 aferições, motor de regras, voz, fila com QR, login e 473 testes

Equipe
3 estudantes de Ciência de Dados e IA, Rio Paranaíba (MG)

Roda local
triagem e voz sem internet; o QR do paciente usa só o Wi-Fi da unidade

Base de treino
casos anonimizados para medir e melhorar a leitura do relato

Perfil clínico
ainda falta na equipe

Máquina na unidade
capaz de rodar os modelos de texto (cerca de 5 GB) e de voz (0,5 GB)

PROPOSTA DE VALOR

Que valor entregamos?

Para o enfermeiro
entrevista guiada por voz ou digitada, próxima pergunta por prioridade e alertas na hora

Para a fila
pontuação de 0 a 100 dentro da cor ordena pacientes da mesma classificação; reclassificar não muda o número

Para o paciente
QR com número, cor, motivo e faixa na fila, e um botão para avisar que piorou

Auditável
cada resultado mostra a regra que o gerou e cada ação na fila registra quem fez

Segurança
a IA nunca decide gravidade nem reduz a pontuação; a decisão é do profissional

Entrevistas com enfermeiro e médico: o que se repete e o que seria perigoso automatizar

RELACIONAMENTO

Como nos relacionamos com os clientes?

Piloto acompanhado
equipe presente na unidade no começo

Treino e suporte
para quem faz a triagem

Revisão periódica
das regras junto com os clínicos da unidade

CANAIS

Como chegamos aos clientes?

Piloto em uma unidade
a UPA da universidade como porta de entrada

Vendas B2B
contrato direto com OSS, hospitais filantrópicos e a rede privada (hospitais, prontos-socorros e clínicas): abordagem, demonstração e proposta comercial

Contato direto
com gestores de UPAs, OSS e filantrópicos

Compra pública
depois do piloto; o caminho é lento

Vitrine
hackathon, demo e repositório no GitHub

Entender as regras de contratação do setor público

SEGMENTOS DE CLIENTES

Para quem criamos valor?

Quem usa
enfermeiros de triagem de UPAs e prontos-socorros do SUS e da rede privada

Quem é atendido
pacientes, muitos de baixa renda, sem alternativa à rede pública

Quem paga
B2B: organizações sociais de saúde e hospitais filantrópicos; setor público: secretarias municipais

Rede privada
hospitais, prontos-socorros e clínicas particulares; compra mais rápida que a pública

Conversas com gestores de unidades para descobrir quem decide a compra

Ver que sistema de triagem a rede privada já usa e o que a faria trocar

ESTRUTURA DE CUSTOS

Quais são os custos principais?

Equipe
desenvolvimento e manutenção

Revisão clínica
consultoria de enfermeiro ou médico

Regulação e jurídico
enquadramento na Anvisa como software médico e LGPD

Implantação
máquina na unidade, instalação e treino

Nenhum valor levantado ainda

FONTES DE RECEITA

Como ganhamos dinheiro?

Assinatura por unidade
valor ainda a definir

Implantação e treino
cobrados à parte

Nunca venda de dados
a LGPD (art. 11, § 4º) veda lucrar compartilhando dados de saúde

Comparar com o custo atual de software hospitalar para chegar ao preço

O que validar primeiro

1. Se o problema existe como imaginamos: entrevistas com enfermeiro e médico.
2. Se as regras e os pesos fazem sentido: revisão clínica linha a linha.
3. Quem decide e quem paga: conversas com gestores.
4. Quanto cobrar: comparação com software hospitalar.
5. Como contratar: regras de compra pública.
6. Se a voz e o QR funcionam em uso real: microfone com barulho e celular no Wi-Fi da unidade.

Riscos que afetam o modelo

- Software que sugere prioridade clínica provavelmente é dispositivo médico na Anvisa (confirmar).
- A pontuação de 0 a 100 é da equipe; o Protocolo de Manchester não tem escala dentro da cor.

Baseado em "projeto de startup.md", "resumo e pontos de atenção.md" e "legislação.md" (pasta arquivos de arquitetura) e no estado atual do protótipo. Todos os dados do protótipo são simulados.